



การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง

Diseases Registry

นพ.พสิษฐ์ สุลักษณ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
17 มิถุนายน 2568



ลักษณะสำคัญ

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



เน้นข้อมูล โรคเฉพาะเจาะจง

- ทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง
- ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- ทะเบียนโรคหัวใจ
- ฯลฯ



จัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ

- ประวัติการเจ็บป่วย
- การวินิจฉัย
- การรักษา
- ผลการรักษา
- ภาวะแทรกซ้อน



ใช้สำหรับการ ติดตามระยะยาว

ช่วยประเมินผลลัพธ์ของ
การรักษา แนวโน้มการเจ็บป่วย
หรือการรอดชีวิต



ช่วยวางแผน และจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย



เน้นความถูกต้อง และปลอดภัยของข้อมูล

มีมาตรการควบคุมการเข้าถึง
และการใช้ข้อมูล

ประโยชน์ของ Disease Registry

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



ประชาชน

- ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
- การเข้าถึงการรักษาใหม่ ๆ
- ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ระบบสาธารณสุข

- การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
- การเฝ้าระวังโรค
- การประเมินผลกระทบของนโยบาย
- การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษา



บุคลากรทางการแพทย์

- การปรับปรุงแนวทางการรักษา
- การติดตามผลการรักษา
- การประเมินคุณภาพการรักษา
- การวิจัยและพัฒนา

นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบาย

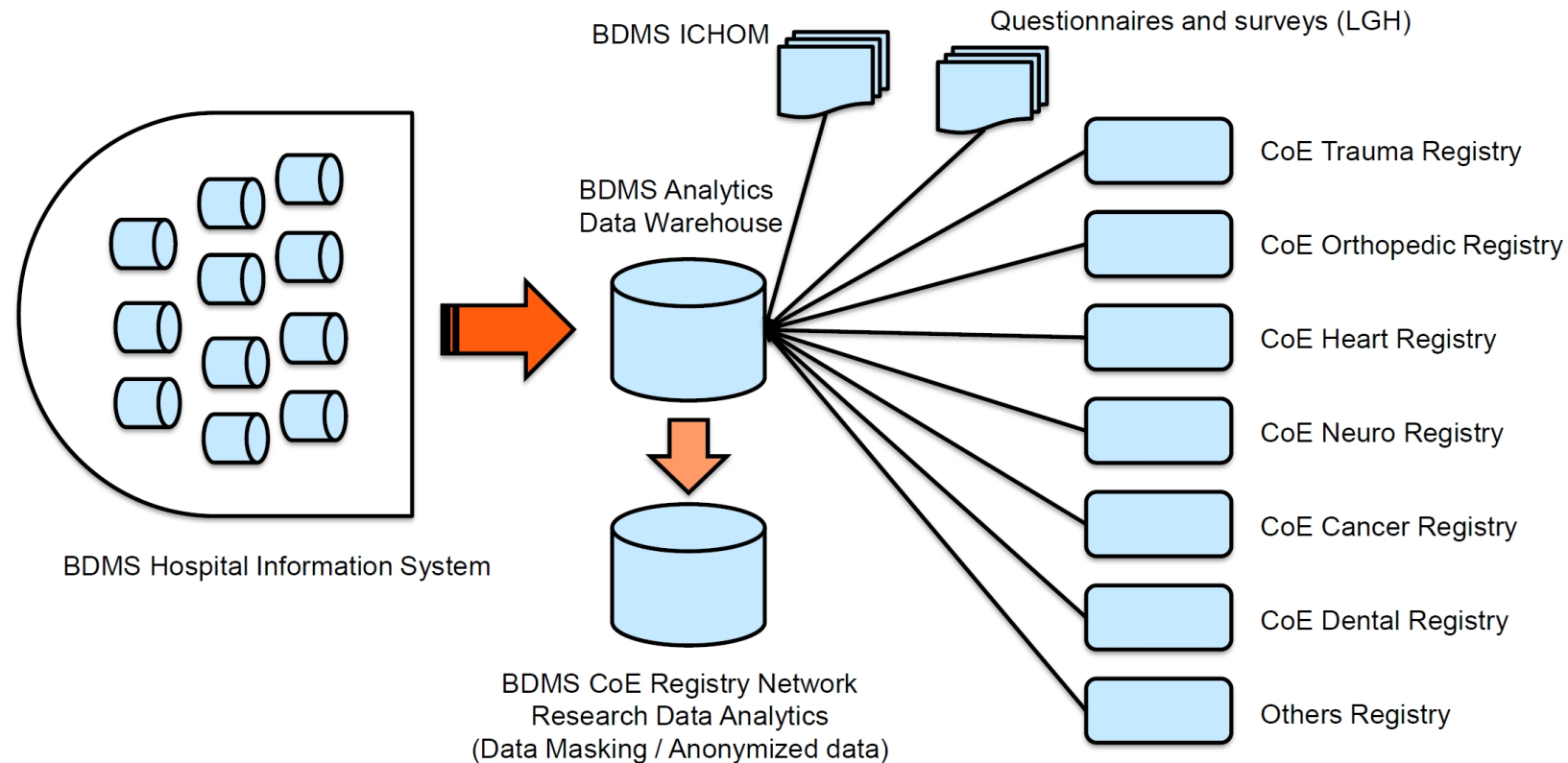
- การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์
- การระบุความต้องการในการวิจัย
- การติดตามความก้าวหน้า

ตัวอย่างการพัฒนาระบบของ BDMS

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Diseases Registry)



BDMS data repository structure for CoE registry and research



Conceptual Farmwork

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Registry)



กลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Registry)



ระยะที่ 1 = 7 กลุ่มโรค



โรคเบาหวาน



โรคความดันโลหิตสูง



โรคหลอดลมอักเสบ/
ปอดอุดกั้น/ถุงลมโป่งพอง



โรคอ้วนลงพุง



โรคหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ



โรคไขมันในเลือดสูง



ผู้สัมผัสไฟฟ้า

ระยะที่ 2



โรคเอดส์



โรคจิตเวช

+

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Registry)



Definition

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Registry)



ICD 10: Ischemic heart diseases I20-I25

- [I20](#) Angina pectoris
- [I21](#) ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction
- [I22](#) Subsequent ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction
- [I23](#) Certain current complications following ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction (within the 28 day period)
- [I24](#) Other acute ischemic heart diseases
- [I25](#) Chronic ischemic heart disease

DxHT (<=90 วัน/ ปีละ 1 ครั้ง)
1)SBP >=140 mmHg (X2)
2)DBP >=90 mmHg (X2)

DxDM (<=90 วัน/ ปีละ 1 ครั้ง)
1)FBS (320062) >=126mg/dL
2)OGTT(320355,320360) >=200mg/dL
3)HbA1C (320131)>=6.5mg/dL

DxCKD (90-120 วัน/มีผล Cr> 1 ครั้ง/ปีละ 1 ครั้ง)
1) Cr(320055) mg/dL
2) Urine microalbumin (320628) mg/dL
N 18.1, N18.2
Urine microalbumin/urine Cr (320142)
mg microalbumin/ mg creatinine >= 3 mg/mmolหรือ >= 30 mg/g

DX COPD
1) ตรวจ Spirometry (ICD9 8873) AND
2) CXR (ICD9 87.44)

DX DLD (ปีละ 1 ครั้ง)
1) Triglyceride(320072) >= 150 mg/dl
2) Cholesterol (320070) >= 200 mg/dl

Dx โรคอ้วน (ปีละ 1 ครั้ง)
Wt kg/ Ht m²

DxSTROKE
CT brain (ICD9 87.03)
DX STEMI
EKG (ICD9 794.31)

DM E10-E14
HT I10-I15
CKD N18
AMI/OTHER/CMi I20-I25
STROKE I60-I69
COPD J44
DLD E78
OBESE E66

ตารางที่ 1 การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังตามเกณฑ์ของอัตราการกรองของไต

ระยะของโรคไตเรื้อรัง	อัตราการกรองของไต (มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
ระยะที่ 1	≥ 90
ระยะที่ 2	60-89
ระยะที่ 3a	45-59
ระยะที่ 3b	30-44
ระยะที่ 4	15-29
ระยะที่ 5	< 15

หมายเหตุ โรคไตเรื้อรังคือภาวะไตเสื่อม หมายถึง โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีระดับอัตราการกรองของไตต่ำกว่า 6 มล./นาที/1.73 ตร.ม. หรือจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง

ระยะที่ 1 N18.1
ระยะที่ 2 N18.2
ระยะที่ 3a N18.31
ระยะที่ 3b N18.32
ระยะที่ 4 N18.4
ระยะที่ 5 N18.5
End stage Renal
disease N18.6
Chronic kidney
unspecified N18.9

$$GFR = 141 \times \min(Scr/k, 1)^{\alpha} \times \max(Scr/k, 1)^{-1.209} \times 0.993^{Age} \times 1.018[\text{if female}] \times 1.159[\text{if black}]$$

$k = 0.7$ if female
 $k = 0.9$ if male

$\alpha = -0.329$ if female
 $\alpha = -0.411$ if male

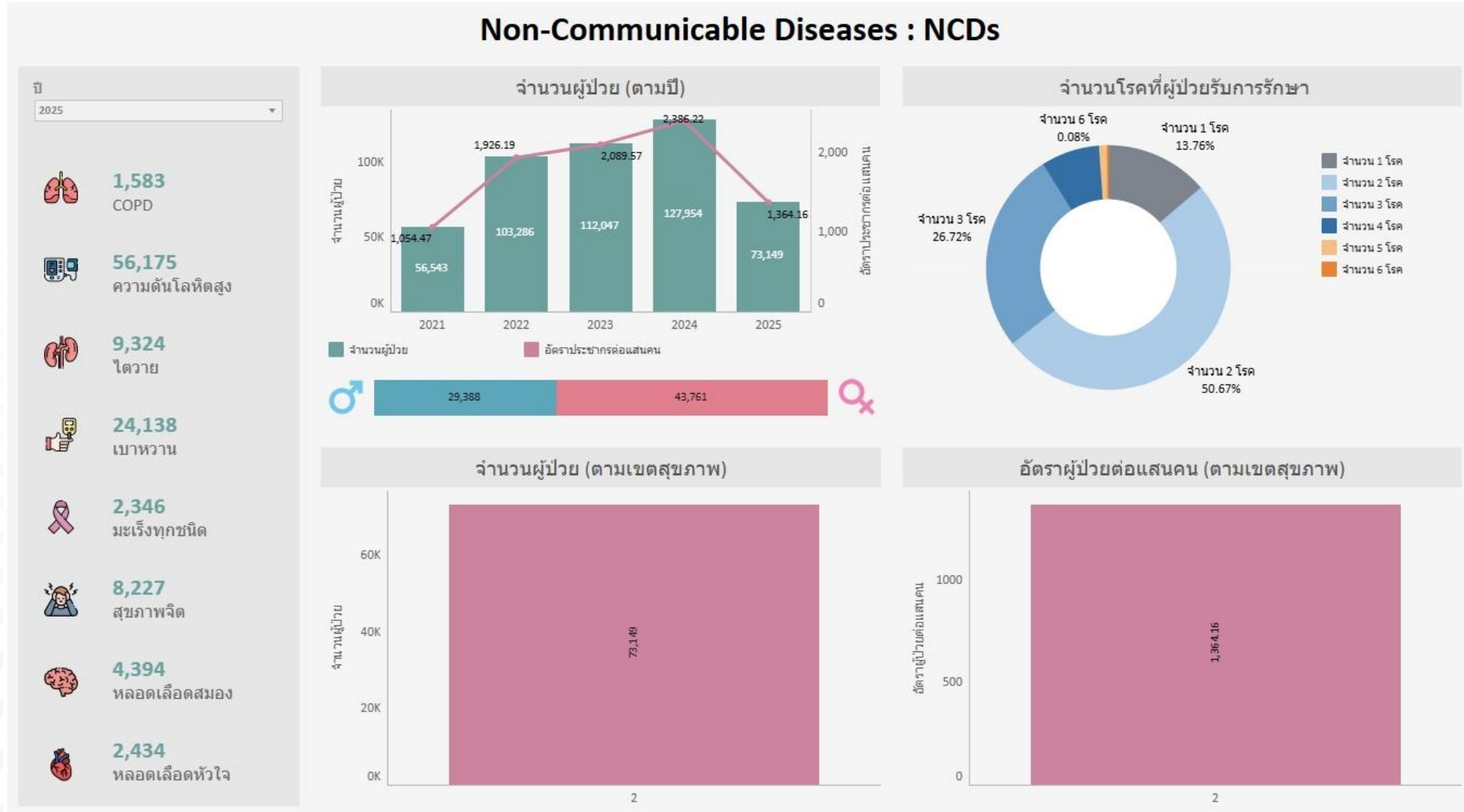
min = The minimum of Scr/k or 1
max = The maximum of Scr/k or 1

Scr = serum creatinine (mg/dL)

ระยะ	ปริมาณอัลบูมิน ในปัสสาวะ (มก./24 ชั่วโมง)	สัดส่วนของอัลบูมินต่อครีเอตินีนในปัสสาวะ		คำนิยาม
		(มก./มิลลิโมล)	(มก./กรัม)	
A1	< 30	< 3	< 30	ปกติ หรือ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
A2	30 - 300	3 - 30	30 - 300	เพิ่มขึ้นปานกลาง
A3	> 300	> 30	> 300	เพิ่มขึ้นมาก

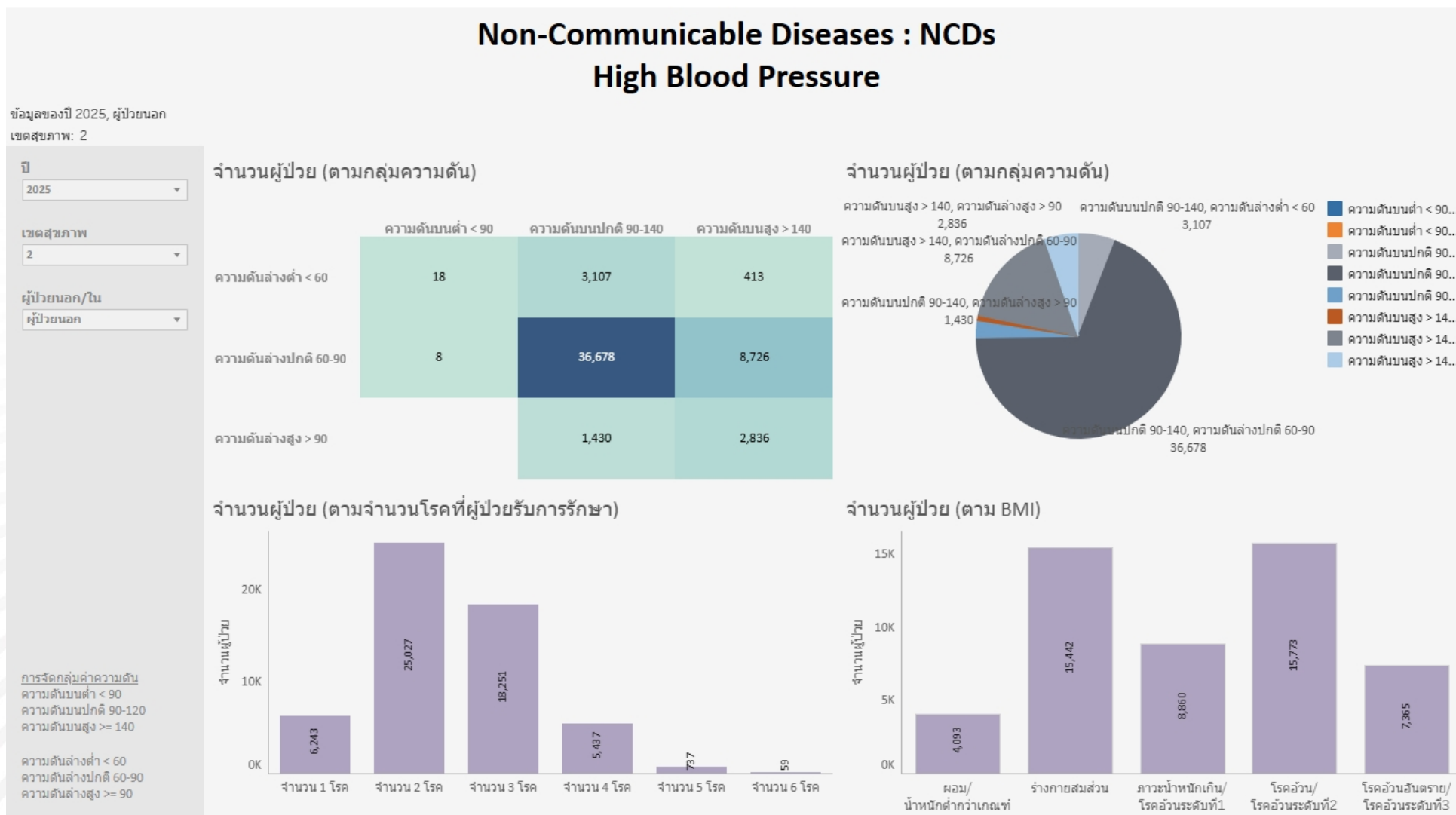
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs)

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



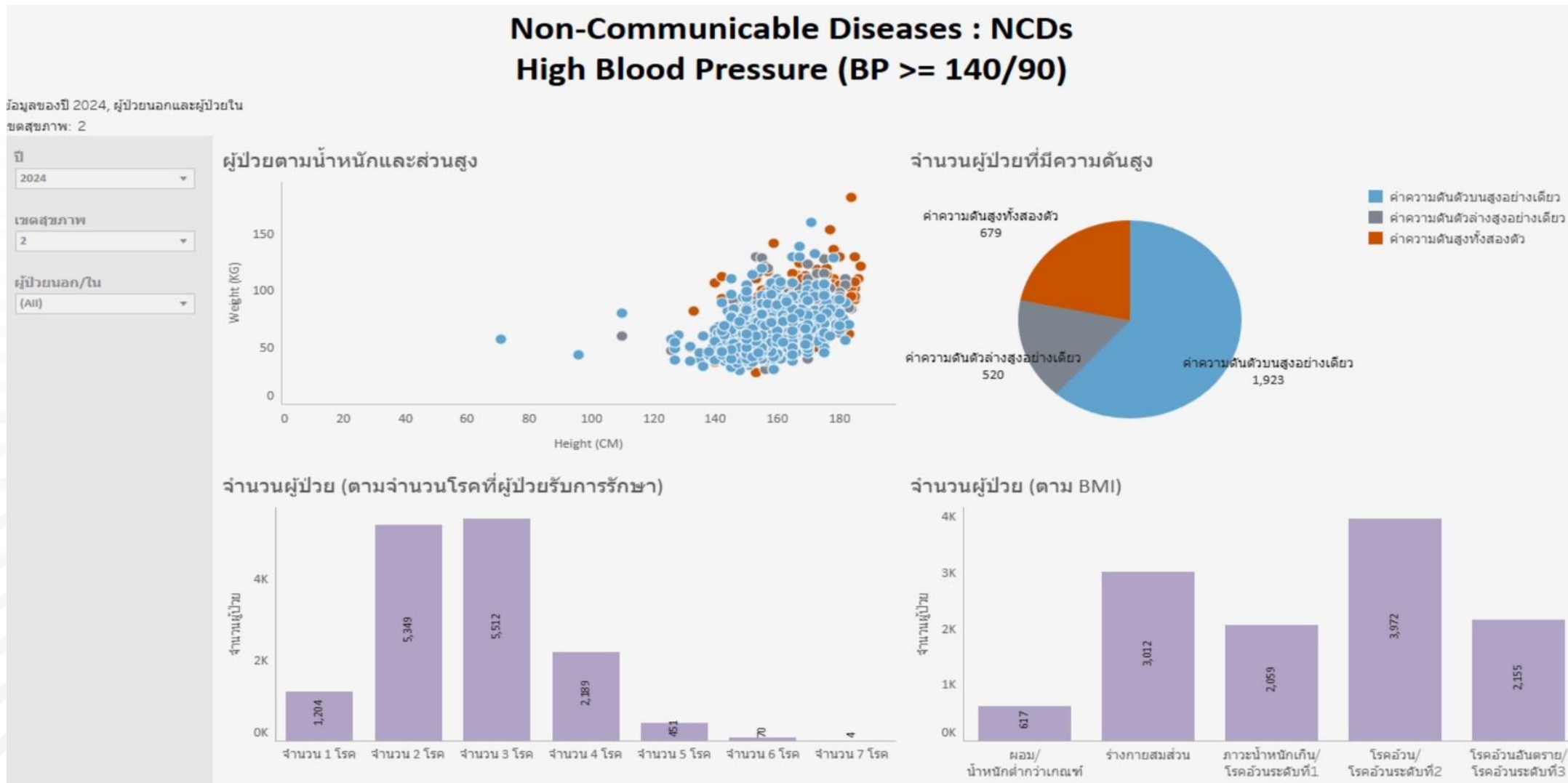
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs)

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



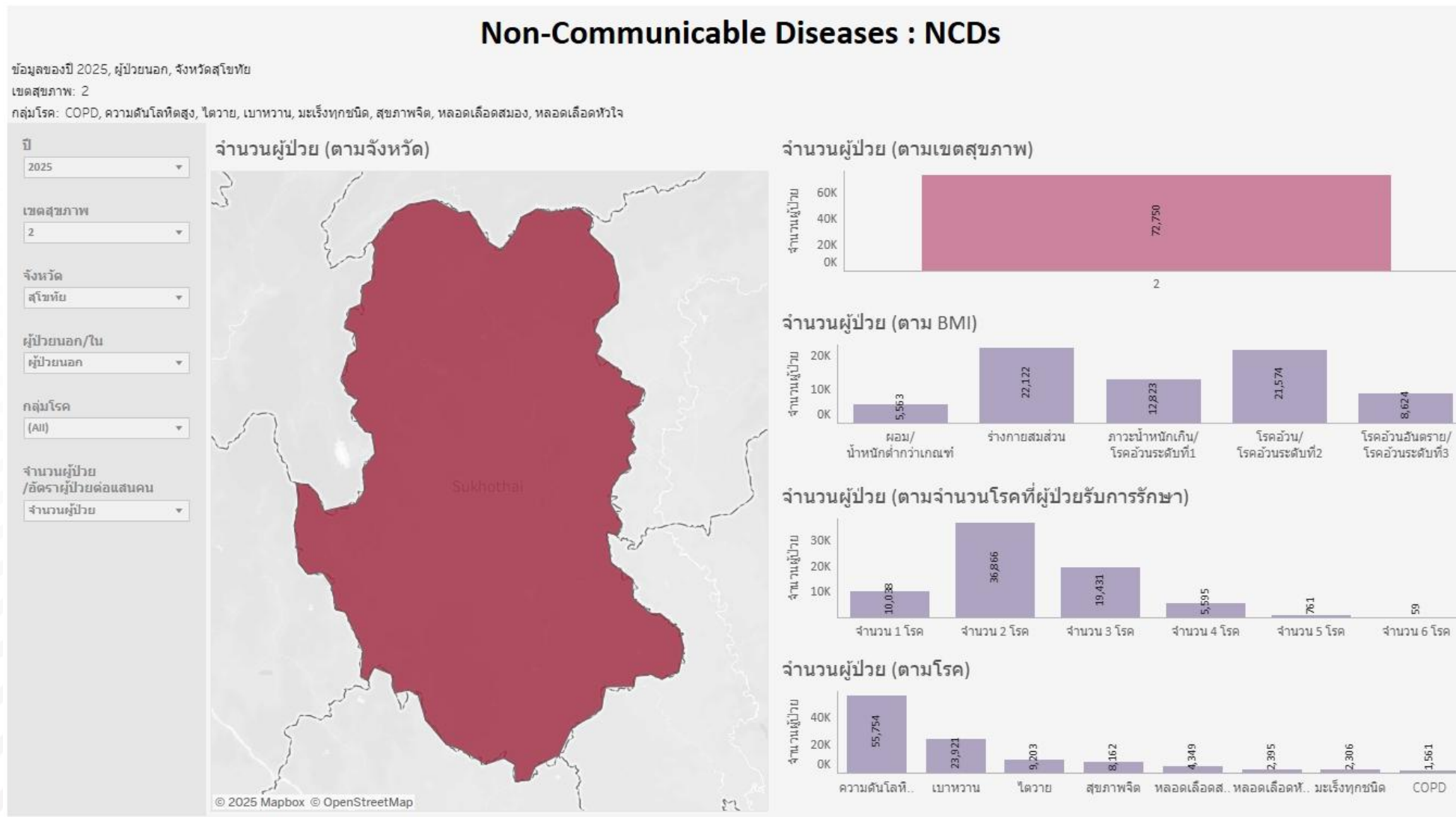
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs)

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



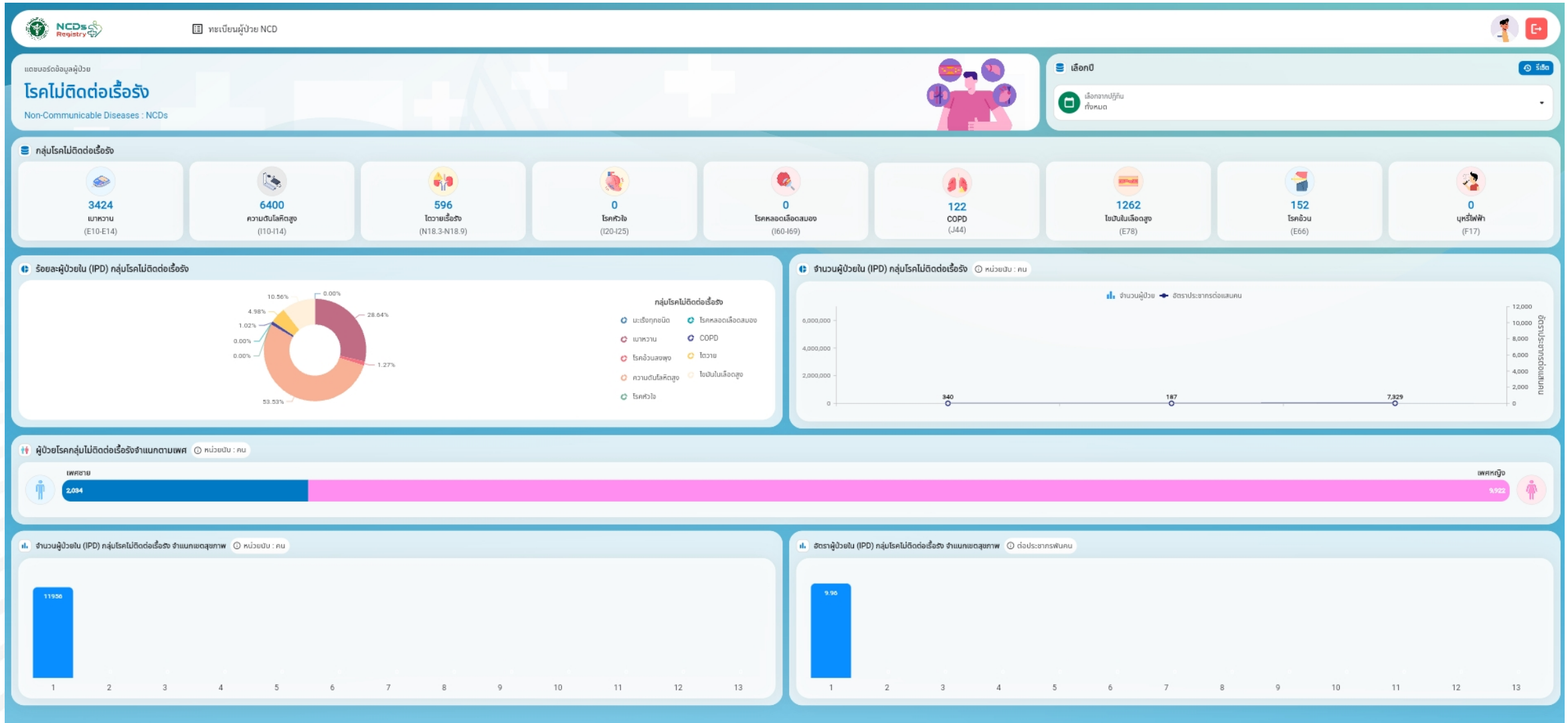
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs)

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



Dashboard

ระบบ NCDs Registry



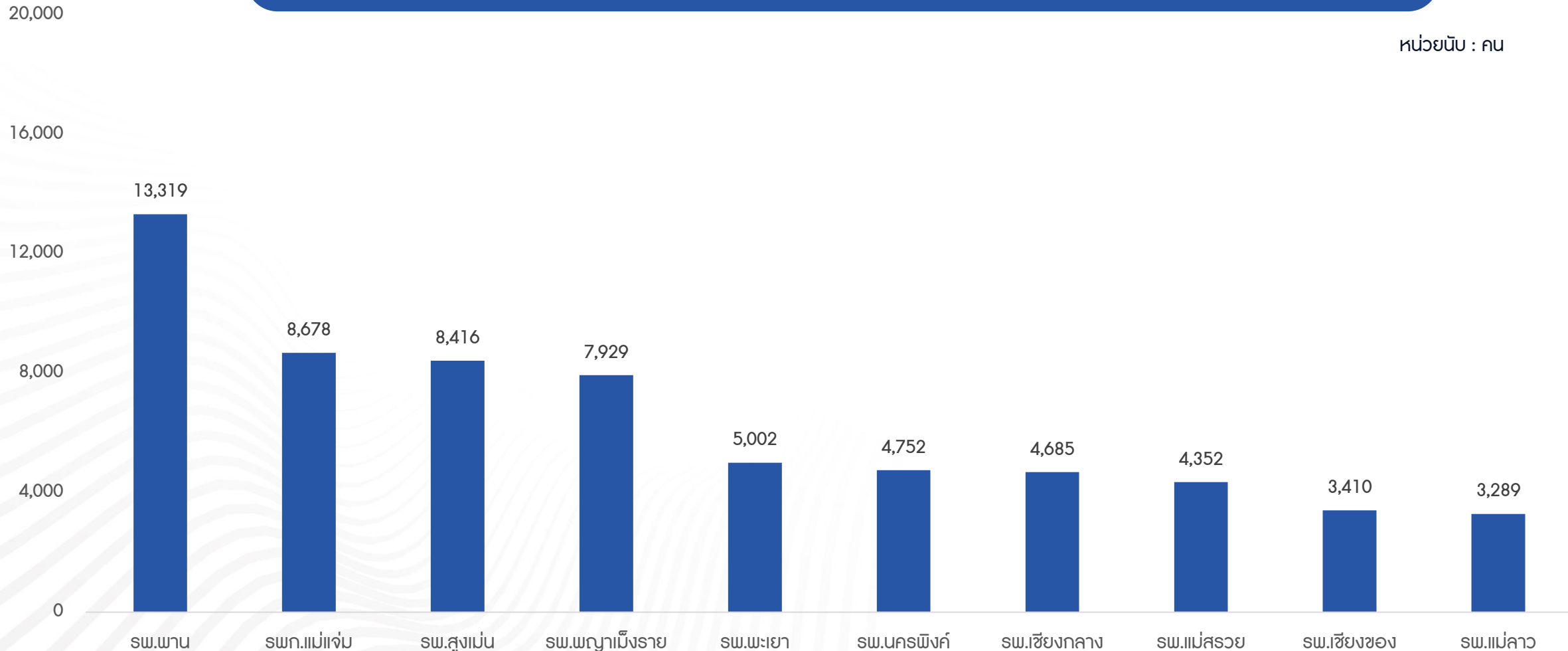
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ

ระบบ NCDs Registry



10 อันดับ หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

หน่วยนับ : คน



Timeline

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Diseases Registry)



เตรียมความพร้อม และ นำร่อง เขตสุขภาพที่ 1

ทะเบียนผู้ป่วย
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง

พ.ศ. – ปี.ย. 68



Pink Book

สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก

ก.ย. – ต.ค. 68



ER Fast track Registry

ทะเบียนผู้ป่วย
ระบบเร่งด่วนในห้องฉุกเฉิน

ม.ค. – ก.พ. 69



NCDs Registry

ทะเบียนผู้ป่วย
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง

ก.ค. – ส.ค. 68



Dental Registry

ทะเบียนผู้ป่วย
ด้านทันตกรรม

พ.ย. – ธ.ค. 68



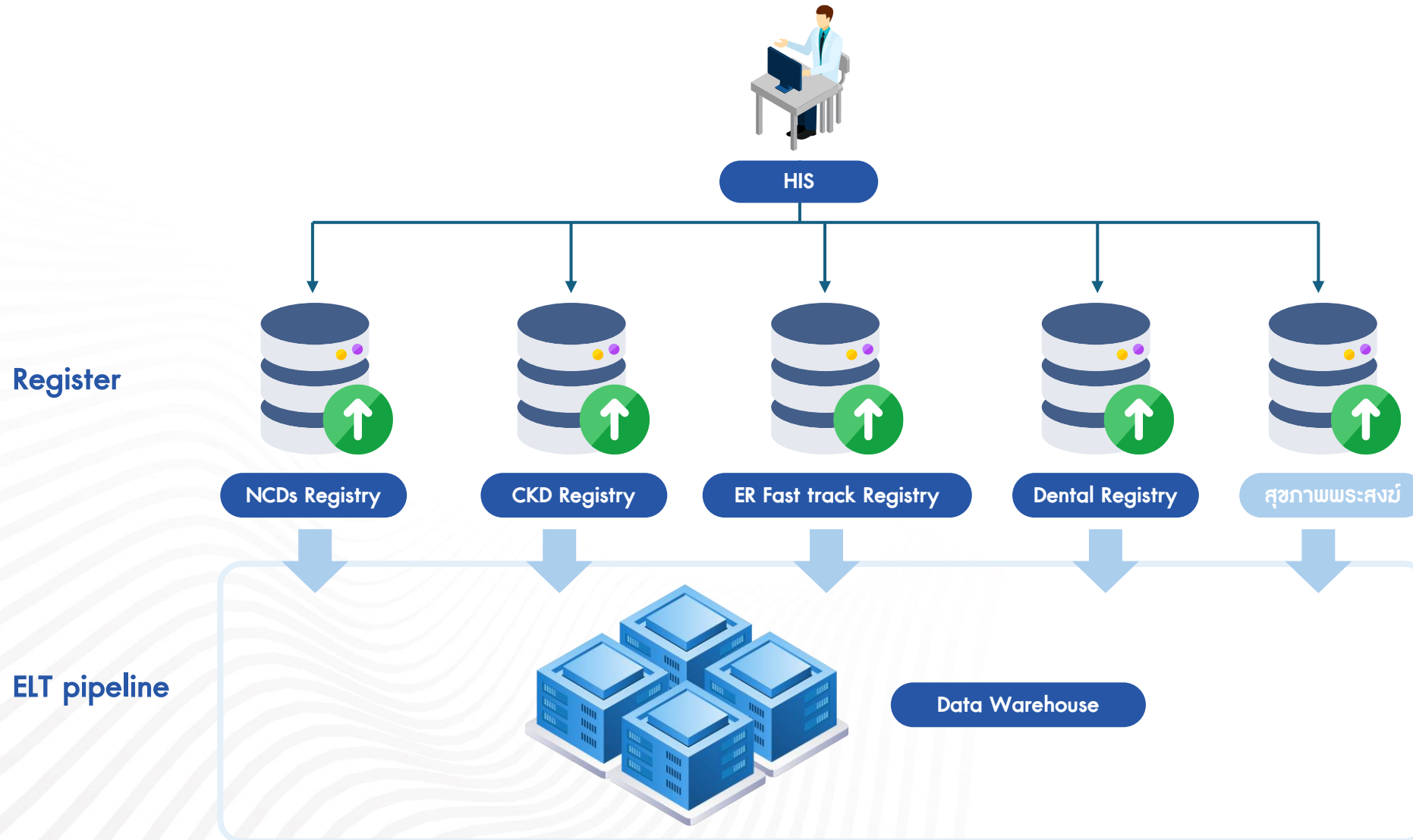
CKD Registry

ทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

มี.ค. – เม.ย. 69

การพัฒนา Data Warehouse

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Diseases Registry)



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

การพัฒนาระบบทะเบียนผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (Disease Registry)



01

ขอเชิญชวน รพศ./รพท./รพช. ที่พร้อมเข้าร่วมระบบ Diesses Registry
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ขอบคุณครับ